جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : فاطمه عبد المنعم محمد مصطفي
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** البساتين **العنوان :** 00000
رقم البطاقة : 25012060400205 **رقم التليفون :** 01000888934 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 24-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 06-12-1950 **المهنة :** بدون عمل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: فاطمه عبد المنعم محمد مصطفى
National ID: 25012060400205

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جوستاف روسي

مبـــادرة رئيس الجمهورية
لدعـم صحة المرأة المصرية

10/19/2026

MDT FORM

Name:	فاطمه عبدالمنعم محمد مصطفى	**MRN:**	12056
Age:	76 Y	**ID:**	25012060400205
Menopausal Sta		**Phone:***	01000888934
NRS SCORE:		**Marital Status:**	
BMI:		**Family History:**	-VE
Gender			
CO Morbidity:	HTN	**Reason Of MDT:**	POST OP
Surgical History:*	HYSTERECTOMY APPENDECTOMY PUH	**ECOG Performance Status**	○ 0◉ 1○ 2○ 3○ 4

Clinical Data:

BX: IMC GII

ER: 8//8 **PR:** 8/8 **HER2:** 0 **KI67:** 5

History:

Sonomammography:

Biomarker/Molecular

Mets Workup:

POST UPFRONT RT SM +SLNB

INVASIVE MUCINOUS CARCINOMA G 2

LOW GRADE DCIS

FREE MARGINS AND NIPPLE AND AREOLA

LN 0/6

T1CN0

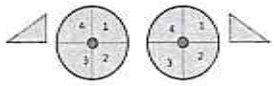
Recommendations:

MDT Outcome & Plan

FOR ADJ AI +ZOMETA/6MS

NEW ASSESSMENT /6MS

R L



T N M

Right Side				Left Side			
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

Clinical Staging:

Pathological Staging:

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د نرمين مصطفي	د.محمد تيراوي		

د/ محمد تيراوي د/ نرمين مصطفي

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

فرع السويس

إدارة شئون المستفيدين

الى من يهمه الأمر / جوستاف لاروسى انتر ناشيونال مصر

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى قانون الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، والذي يتضمن بوجوب خضوع المقيمين بمحافظات التطبيق إجبارياً بالمنظومة وفقا لمحل الإقامة ببطاقة الرقم القومي داخل إحدى محافظات التطبيق ، وبالإشارة الى بدء التشغيل الفعلي بتاريخ ديسمبر 2024 لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس.

برجاء التفضل بالعلم بأنه قد تم الاستعلام عن بيانات المواطن / فاطمة عبد المنعم محمد مصطفى يحمل بطاقة رقم قومي / 25012060400205 المرفقة طية والتي قد تم إصدارها في تاريخ 4-2025 بمحل الإقامة في محافظة القاهرة وبناءاً على ما سبق في ان المستفيد المذكور من غير الخاضعين لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

مدير الإدارة المالية

مدير شئون المستفيدين

مدير التسجيل والاصدار

مدير عام الفرع

FISH Analysis
[[DOCTYPE:FISH_ANALYSIS]]





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

مبـــادرة رئيس الجمهورية
لدعـم صحة المرأة المصرية

07/19/2026

MDT FORM

Name:	فاطمه عبدالمنعم محمد مصطفى	**MRN:**	12056
Age:	76 Y	**ID:**	25012060400205
Menopausal Status:		**Phone:**	
NRS SCORE:		**Marital Status:**	
BMI:		**Family History:**	
CO Morbidity:		**Reason Of MDT:**	

Clinical Data:

BX:

ER 8/8 **PR** 8/8 **HER** 1 **KI67** 5%

Sonomammography:

Mets Workup:

History:

POSITIVE FOR ESTROGEN RECEPTORS (SCORE 8/8). POSITIVE FOR PROGESTERONE RECEPTORS (SCORE 8 / 8). HER 2 LOW. SCORE 1+. THE PROLIFERATION INDEX OF Ki67 IS 5%. PET scan showed low grade metabolically active D9

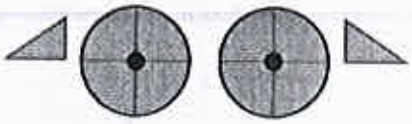
Recommendations:

upfront surgery

MDT Outcome & Plan

for upfront SM and SLND

R L



T N M

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د حنان عزت	د احمد نجيب				

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Fatth Islamic Center

C.T. - M.R.I

U.S. - Duppler - E.C.G. Stress

E.E.G - E.M.G - Mamm - Eye Unit

الجمعية الشرعية

مركز الفتح الإسلامى

أشعة مقطعية بالكمبيوتر - الرنين المغناطيسى
موجات صوتية - دوبلر ملون - رسم قلب بالمجهود
رسم مخ - رسم عضلات - فحص ثدى - وحدة عيون

Name: *Fatama Abdelmoneam Mohmed*
Date: *9 June 2026*

Clinical summary: *75 yrs old female with right breast painful lump.*

DIGITIZED BILATERAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY & REAL TIME ULTRASONOGRAPHY FOR BOTH BREASTS REVEALED:

- *Scattered dense fibroglandular mammary parenchyma of both breasts (ACR b).*
- *The right LOQ (middle third) shows focal asymmetrical increased density with parenchymal distortion and few irregular shaped densities .*
- *Normal skin thickness..*
- *No left breast lesions .Intact left nipple/ areolar complex.*
- **REAL TIME ULTRASONOGRAPHY FOR BOTH BREASTS REVEALED:**
- *Corresponding to mammography right LOQ ill-defined non mass lesion with parenchymal distortion and interconnecting few irregular shaped hypoechoic lesions seen at 8 o'clock middle zone b about 2.5 cm from nipple and 7 mm from skin , the overall process measures about 3.2x1.6 cm .Intralesional vascularity was detected on color Doppler .*
- *No left breast solid or cystic lesions detected*
- *Bilateral nonspesfic axillary nodes.*

OPINION:
Findings are suggestive of suspicious right LOQ process of altered parenchyma and non-mass lesion (BIRADS 4).
No left breast lesions ,.BIRADS 1

- ***Further management & biopsy is recommended.***
- ***Contrast study is recommended .***

Dr. Heba Ahmad . MD.

٥٣ شارع ١٠ بالمعادى، ت : ٢٣٥٨٧٣٣٢ - ٢٣٥٨٥٨١٩ - ٠١٠٠١٨١٣٨٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

NILE SCAN & LABS

مركز النيل للأشعة و التحاليل

Name : Fatima Abdul-Moneim Mohammed Mostafa Al-Batal	**Date : 30-06-2026 06:19**
Branch : Nasrcity	**Medical No. : 405740**
Ref. By Prof Dr Maher Hassan	

Abdomen and pelvis:

- Average-sized liver with no focal lesions or FDG-avid foci. No IHBR dilatation could be detected.
- No significant pathologically enlarged or metabolically active pelvi-abdominal lymph nodes.
- Normal spleen, pancreas, kidneys, suprarenals and pelvic structures.
- No ascites.

Musculoskeletal:

- Low-grade metabolically active DV9 lytic lesion, eliciting SUV max up to 2.3.
- Spondylodegenerative changes are noted.
- No other blastic or lytic bony lesions could be detected all over the surveyed skeleton.



Impression:

Whole body (FDG) PET/CT study is showing:

- FDG avid right breast soft tissue mass lesion as described, matching with the known active tumour biology.
- Suspicious low-grade metabolically active DV9 lytic lesion, "yet inconclusive for metastatic lesion"; warranting MRI correlation and follow up.
- No other FDG avid focal lesions could be detected.
- Follow up FDG PET/CT is advisable as clinically warranted.

Best regards,

Dr. Mohammed Akl, M.Sc

Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

NILE SCAN & LABS

مركز النيل للأشعة و التحاليل

Name : Fatima Abdul-Moneim Mohammed Mostafa Al-Batal	Date : 30-06-2026 06:19
Branch : Nasrcity	Medical No. : 405740
Ref. By Prof Dr Maher Hassan	

Whole Body (FDG) PET/CT Scan

Clinical question:

- 75-year-old lady with recent history of pathologically proven right breast cancer.
- PET/CT is requested for status evaluation.

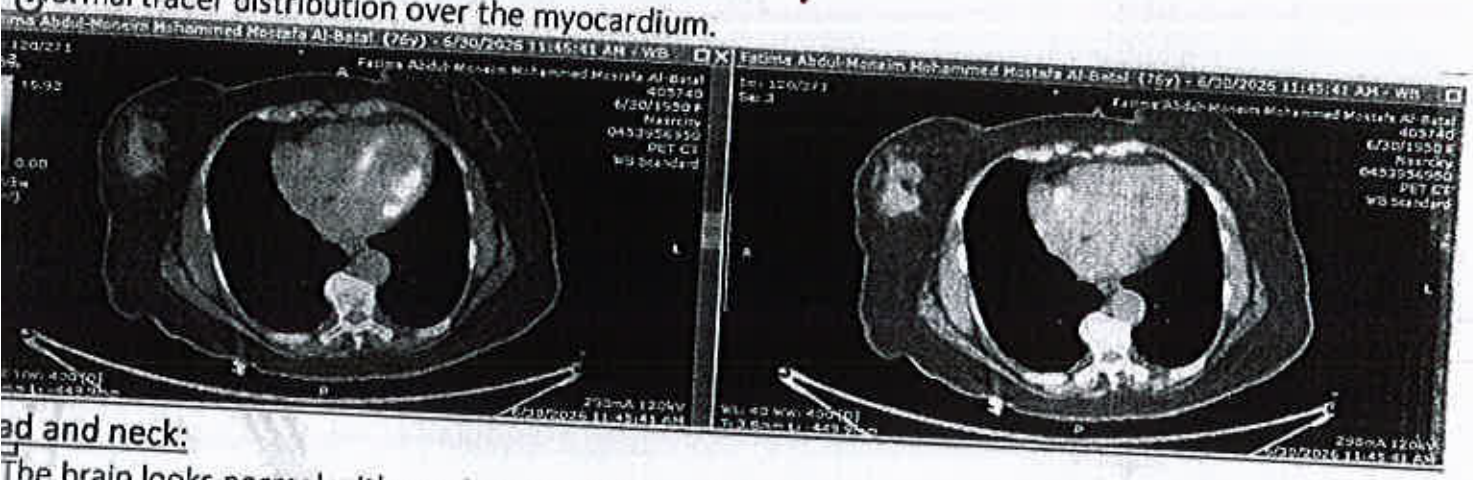
Procedure:

- Dose/Radiopharmaceutical: 4 mCi ^{18}F-FDG administered via a peripheral upper limb vein.
- Blood glucose level: 93 mg/dL.
- Imaging was performed on an integrated PET/CT scanner approximately 60 minutes after injection of the radiopharmaceutical.
- CT without contrast images done for attenuation correction and an anatomic localisation were obtained followed by PET images from the vertex of the skull to the calf region.
- PET/CT images were reviewed in the transaxial, coronal and sagittal planes.
- The Standardised Uptake Value, maximum variant (SUV_{max}) was calculated within regions of interest whenever needed.

Findings:

Chest (including both breasts and related mammary lymph nodes):

- Metabolically active rather defined right breast LOQ irregular soft tissue mass lesion, measuring 4.7x3.3 cm and eliciting SUV max up to 5.7.
- Unremarkable appearance of the left breast.
- No significantly enlarged or dense tracer fixing mammary related LN.s.
- No lung nodules, masses or parenchymal infiltrates.
- No pleural or pericardial effusion.
- Normal tracer distribution over the myocardium.



ad and neck:

- The brain looks normal with no abnormal focal metabolic activity.

(N.B: it may kindly be noted that some brain lesions not to be apparent on PET/CT and MRI is better for local assessment, if clinically warranted).

- Normal FDG uptake pattern is seen at other soft tissues, glandular structures, oropharynx, larynx and alivary glands.
- lo adenopathy or nodal hypermetabolism in the neck.

Call Center 19656

Dr.
Elia Anis Ishak
M. Sc. Ph. D. Pathology - Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow, Armed Forces Institute of Pathology , USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Dr.
Shady Elia Anis
M. Sc. MD Pathology , Ass. Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow , Mass General Hospital , Harvard , USA
Member , United States Canadian Academy of Pathology

Patient Name : فاطمه عبد المنعم محمد مصطفى البطل **Analysis ID :** 1065227
Age : 75 Y : 6 M : 4 D **Gender :** Female **Conf. Code :** 1894
Referred By Prof. Dr. : ماهر حسن
Clinical Diagnosis : Right breast mass, BIRADS 4C
Nature of Specimen : Block (labelled as 1065226 - U/S guided tru cut biopsy)
Receiving Date : 2026-06-11 **Patient ID :** 779253

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Technique :

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain.
The sections were treated against:
- Estrogen receptors -Progesterone receptors - Her 2 - Ki67.

Results :

90 % of tumor cells show STRONG POSITIVE staining for Estrogen receptors.
90 % of tumor cells show STRONG POSITIVE staining for Progesterone receptors.
Sections treated for HER2 reveal MINIMAL INCOMPLETE FAINT CELL MEMBRANE STAINING IN MORE THAN 10% OF TUMOR CELLS.
5 % of tumor cells are POSITIVE for Ki67.

Conclusion :

Block, TUMOR CELLS ARE:
POSITIVE FOR ESTROGEN RECEPTORS (SCORE 8 / 8).
POSITIVE FOR PROGESTERONE RECEPTORS (SCORE 8 / 8).
HER 2 LOW, SCORE 1+.
THE PROLIFERATION INDEX OF KI67 IS 5 %.

Prof. Dr. Shady Elia Anis

Prof. Dr. Elia Anis Ishak

This report is electronically signed , any abrasion or modification would render it void .

DR ELIA ANIS LABS
عمارة رمسيس - بلوك أ - ميدان رمسيس - الدور السادس و السابع
تليفون : ٠١٢١٢٩٤٥١١٥ - ٠١٢٨٧٠٠٥٢١٧ - ٢٥٧٧٣٢٥٣ - ٢٥٧٩٠٩٣٥

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Dr.
Elia Anis Ishak
M. Sc. Ph. D. Pathology - Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow, Armed Forces Institute of Pathology , USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Dr.
Shady Elia Anis
M. Sc. MD Pathology , Ass. Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow , Mass General Hospital , Harvard , USA
Member , United States Canadian Academy of Pathology

Patient Name : فاطمه عبد المنعم محمد مصطفى البطل **Analysis ID :** 1065226
Age : 75 Y : 6 M : 4 D **Gender :** Female **Conf. Code :** 5847
Referred By Prof. Dr. : ماهر حسن
Clinical Diagnosis : Right breast mass, BIRADS 4C
Nature of Specimen : U/S guided tru cut biopsy
Receiving Date : 2026-06-11 **Patient ID :** 779253

PATHOLOGY REPORT

Gross :

Multiple tan yellow tissue cores, the longest measured 1 cm, totally submitted.

Microscopic :

Sections examined from the specimen received reveal cores of tumour tissue formed of malignant ductal epithelial cells, showing moderate nuclear pleomorphism and hyperchromasia. There is poor attempt at tubular formation, with focal micropapillary features and excess mucous production.
The mitotic index is low.
There is moderate desmoplasia and no necrosis.
There is peritumoural lymphocytic infiltrate around 3 %.
There is intraductal component about 60 %, showing solid and cribriform patterns.

Diagnosis :

Right breast mass, U/S guided tru cut biopsy,
INFILTRATING DUCT CARCINOMA WITH MUCOUS PRODUCTION AND FOCAL MICROPAPILLARY FEATURES, GRADE II.
- HORMONAL RECEPTORS IN A SEPARATE REPORT.

Prof. Dr. Shady Elia Anis *Prof. Dr. Elia Anis Ishak*

This report is electronically signed , any abrasion or modification would render it void .

DR ELIA ANIS LABS
عمارة رمسيس - بلوك أ - ميدان رمسيس - الدور السادس و السابع
تليفون : ٠١٢١٢٩٤٥١١٥ - ٠١٢٨٧٠٠٥٢١٧ - ٢٥٧٧٣٢٥٣ - ٢٥٧٩٠٩٣٥

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name : Fatima Abdul-Moneim Mohammed Mustafa Al-Batal
Branch : New Cairo
Ref.Physician Prof : Tamer Alnhas

Date : 06-07-2026 09:06
Medical No. : 410036
Ins.Company : جلوب مد

MRI EXAMINATION OF THE DORSAL SPINE

Technique :
Sagittal T1, T2
Axial T2 FFE

Findings:

- Preserved dorsal curve with good vertebral alignment
- No vertebral structural collapse or marrow signal alteration.
- Multi-vertebral hemangiomata.
- Marginal anterior osteophytic lipping of the opposing vertebral end plates.
- Reduced height and normal bright T2 signal of the dorsal discs.
- D9/10 mild small focal posterior disc protrusion seen effacing the anterior CSF space and just touching the cord.
- Normal caliber & MR signal of the dorsal cord. No cord oedema, malacia or syrinx.
- No paravertebral masses or collections

OPINION:

❖ **Dorsal spondylosis with D9/10 mild posterior disc lesion, for clinical correlation of its significance.**

Dr. Zeyad El-Sayed, FEBR
Radiology Consultant

M.R.I
[[DOCTYPE:MRI]]

[[DOCTYPE:MRI]]
M.R.I

Name : Fatima Abdul-Moneim Mohammed Mustafa Al-Batal Date : 06-07-2026 09:06
Branch : New Cairo Medical No. : 410036
Ref.Physician Prof : Tamer Alnhas Ins.Company : جلوب مد

MRI EXAMINATION OF LUMBOSACRAL SPINE

Technique :
Sagittal T1, T2
Axial T2
Axial T1

Findings:

- Preserved lumbar curve with good vertebral alignment
- No vertebral structural collapse or marrow signal alteration.
- Marginal anterior osteophytic lipping of the opposing vertebral end plates.
- Reduced height & normal bright T2 w signal of the lumbar discs.
- L3/4 mild biposterolateral disc protrusion seen effacing the anterior epidural space and minimally encroaching upon the inferior recesses of both neural exit foramina more inclined to the left.
- L4/5 diffuse posterior disc bulge seen effacing the anterior epidural space, indenting the thecal sac and encroaching upon both corresponding neural exit pathways.
- Hypertrophied L2/3 & L3/4 level ligamenta flava.
- Normal MR signal of the conus medullaris & cauda roots.
- Bilateral L4/5 & L5/S1 facetal arthropathy.

OPINION:

- **Lumbar spondylosis with L3/4 & L4/5 posterior discs lesions as described.**

Dr. Zeyad El-Sayed, FEBR
Radiology Consultant

DIAGNOSTIC CENTER